

05 - 05- Tumeurs médiastinales - Pr. Bouchentouf

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui c'est les tumeurs médiastinales. En guise d'introduction, les tumeurs médiastinales sont un groupe hétérogène et polymorphe de tumeurs qui peut être maligne ou bénigne, peut être symptomatique ou asymptomatique de découverte radiologique. La thaléméthorastie a un intérêt très très important dans la démarche diagnostique, mais le diagnostic est surtout histologique et le traitement dépendra surtout de l'étiologie.

Le rappel anatomique, le médiastin c'est un espace, un carrefour entre les deux poumons. Il est limité en avant par la fourchette, le sternum. Et en arrière par la colonne vertébrale.

Il va être subdivisé en étage et en plan. Si on part de l'étage supérieur, donc ce qui est au-delà de la crosse, de l'aorte, il est supérieur. Entre la crosse et la carène c'est moyen, et sous la carène il est inférieur.

Et par rapport au plan, en plan antérieur, moyen et postérieur, le plan antérieur en avant de la trachée, en plan moyen dans l'axe de la trachée, et en arrière de la trachée c'est le plan postérieur. Ce qui concerne le diagnostic, les circonstances de découverte de ces masses médiastinales, c'est souvent à l'occasion d'un syndrome de compression médiastinale. Le médiastin est un carrefour pour les structures respiratoires, digestives, nerveuses, vasculaires, artérielles ou veineuses.

On peut avoir soit une compression bronchique ou trachéale, une compression nerveuse, particulièrement le nerf œœurant gauche, une compression veineuse, on va avoir le fameux syndrome CAF supérieur, également compression de d'autres structures digestives, l'œsophage, œœrique et compression, c'est plus rare. Également, découverte à l'occasion d'anomalies extrathoraciques, qui peut être neurologiques, qui peut être cutanées, qui peut être digestives ou autres, qui va orienter vers les étiologies. Également, peut-être, découverte radiologique.

L'imagerie thoracique est très importante dans la démarche diagnostique des tumeurs aux masses médiastinales. En premier temps, c'est la radiographie thoracique face et profil qui va caractériser ces masses et ces opacités médiastinales. Il y a des signes radiologiques qui permettent l'orientation, la localisation de ces masses, mais surtout, la tomodensitométrie, en utilisant des différences de densité des structures composant la paroi thoracique, et en cas de contre-indication de tête intéressée, on peut utiliser l'hierme thoracique.

D'autres examens seront utilisés ou demandés en fonction du contexte et du siège de cette masse médiastinale. Particulièrement, il y a l'endoscopie bronchique ou œsophagienne, l'œœoendoscopie œsophagienne ou l'opacification vasculaire ou digestive. La radiographie thoracique face, et surtout de profil, permet de caractériser l'opacité de type médiastinal.

L'opacité de type médiastinal est à la limite externe nette, soit raccordant un pont doux avec le médiastin, et sa limite interne est invisible. Pour le repérage topographique, on va utiliser des

signes radiologiques, qu'on appelle les signes de convergence des riles, les signes de la silhouette, les signes de recouvrement des riles, les signes cervicothoraciques, et également les signes thoraco-abdominaux, qu'on appelle les signes de l'iceberg. La radiographie thoracique de face montre une opacité à la limite externe nette et à la limite interne noyée dans le médiastin.

C'est une opacité de type médiastinal. Cette opacité, dont la limite supérieure reste visible au-delà du clavicule, c'est une opacité médiastinale postérieure, c'est le signe cervicothoracique. Lorsque la masse médiastinale reste visible au-delà de la clavicule, elle est postérieure.

Lorsqu'elle distalle ses faces au-delà de la clavicule, elle est antérieure. La TDM thoracique est très importante dans le cas de pathologies médiastinales. La TDM thoracique, avec l'injection de produits de contraste, permet de mesurer la densité des structures médiastinales, de la masse médiastinale, également de préciser les rapports de cette masse avec les structures adjacentes, surtout les structures vasculaires.

Également, cet endométrique permet de réaliser des prélèvements histologiques. On a dit que le détenu est surtout histologique. La TDM thoracique nous permet d'assurer des prélèvements histologiques grâce à la fonction transpiral scanogydée.

La TDM thoracique est également utilisée comme un moyen, comme un examen, dans le cas du bilan de gestion, dans le cas des processus tumoraux malins. Pour se créer des diagnostics histologiques, il faut chercher les signes extra-thoraciques qui sont très importants. On a dit qu'il peut y avoir des signes neurologiques, comme la myasthémie, qui va orienter vers un tumeur médiastin que l'on appelle les masses thymiques.

On recherche également des signes cutanés, l'irritement, qui peut orienter vers la primo-infection tuberculeuse ou la sarcoïdose, les tâches caféolées, qui vont orienter vers des tumeurs nerveuses. Également, on cherchera des signes de dysthyroïdes, qui vont orienter vers un goitre thyroïdien. Également, on va chercher des signes de gynécomastie, qui peuvent orienter vers des tumeurs germinales.

L'image est thoracique, donc on va dire que cette masse est au niveau du médiastin antérieur. Ça dépendra de l'étage supérieur et moyen et de l'étage inférieur. Les masses du médiastin antérieur, de l'étage supérieur et moyen les plus fréquentes sont le goitre endothoracique, les tumeurs thymiques, les tumeurs nerveuses, les adénomes parathyroïdiens, généralement les anévrysmes de la veine ascendante.

Et l'étage inférieur, on aura des kystes pleurs péricardiques, l'ernie de la fente de la raie et des franges graisseuses péricardiques. Grosso modo, les tumeurs du médiastin antérieur les plus fréquentes sont les goitres, les tumeurs thymiques et les tumeurs germinales en cas d'étage supérieur et moyen et en cas d'étage inférieur on cherche les kystes pleurs péricardiques. Pour ce qui est du médiastin moyen, c'est souvent les adénopathies médiastinales, qui peuvent être

bénines et malignes.

En cas d'adénopathie médiastinale bénigne, c'est le cas de la sarcoïdose, de la tuberculose, de la pneumoconiose, également peut être maligne, en cas d'adénopathie maligne. Également les masses ou les tumeurs du médiastin moyen, on peut avoir des kystes bronchogéniques, également on peut avoir de l'hernie hiatale. Pour le médiastin postérieur, c'est surtout les tumeurs neurogènes, mais on peut avoir des tumeurs vertébrales, les tumeurs, les pathologies oesophagiennes et l'anévrysme de l'aorte descendante.

Pour ce qui est du diagnostic étiologique, on aura un bilan, si on pense au goitre, les thyroïdites, on cherchera des hormones thyroïdiennes, si elles sont anormales, c'est un goitre endocrinien, le beta-TG, l'alpha-proteine, lorsqu'on suspecte des tumeurs germinales, les anticorps, les anticholines cholinergiques, lorsqu'on suspecte un diagnostic de tumeur devant les signes de myasthénie, également l'électrophorèse de protéines et l'intradermoréaction à la tuberculine. Le diagnostic est surtout étiologique, apporté par des techniques de diagnostic, la ponction biopsique sous scanner, l'exploration du médiastin soit par médiastinoscopie ou par médiastomie, également on peut faire une thoracotomie. Pour ce qui est de l'étiologie, au cas de la tumeur du médiastin antérieur, on aura le goitre plongeant, le goitre plongeant peut être asymptomatique, un goitre peut être révélé par des signes de compression respiratoire et nerveuse, la trachée entraîne une dyspnée, une nerveuse, une paralysie acupuncturale.

L'examen clinique, parfois on examine le pôle supérieur de la thyroïde, on recherchera le pôle supérieur de la thyroïde. Et surtout l'examen orolaryngé, à la recherche de signes de paralysie des cordes vocales, traduisant la compression d'une aorte récurrente gauche. La TDM thoracique nous va confirmer la nature thyroïdienne, complétée par un bilan thyroïdien, une scintigraphie thyroïdienne.

Pour ce qui concerne également les autres tumeurs du médiastin antérieur supérieur, ce sont les tumeurs les plus fréquentes, les tumeurs. Elles constituent 50 à 60% des tumeurs du médiastin antérieur. Les tumeurs chimiques sont formées par deux contingents cellulaires malins et bénins, un contingent lymphocytaire.

Cette tumeur peut être asymptomatique, mais surtout lorsqu'on évoque une tumeur, il faut rechercher des signes extra-thoraciques, c'est-à-dire la médiastinopathie. Et la biologie, on recherchera les anticorps antiléo-cholestéroliques et on fera une hypogammaglobulinémie. L'électrophorèse de protéines, elle recherche une hypogammaglobulinémie.

Devant toute masse du médiastin antérieur avec une médiastinopathie, il faut penser aux tumeurs. Les tumeurs germinales, ce sont des tumeurs rares, ce sont des tumeurs d'origine embryonnaire. On distingue les tératomes, ce terme tératome vous allez le voir en cas des tumeurs du testicule chez l'homme.

Également les tumeurs germinales non-séminomateuses, mais lesquelles les tératomes matures

ou immatures, les carcinomes embryonnaires et les choriocarcinomes. Les simulums, ce sont des tumeurs de langue jeune. Donc l'intérêt de les rechercher, d'autres localisations en particulier testiculaires, de l'intérêt de l'examen des testicules chez les langues jeunes.

Leur traitement est basé sur la chirurgie associée au nom à la radiothérapie. Les teratomes touchent les sujets jeunes, mais surtout l'aspect hormonal, symptomatique et les traits évocateurs avec la présence de plages de densité liquidienne, graisseuse et calcification. Le traitement est chirurgical.

Pour ce qui est des choriocarcinomes, ce sont des tumeurs de haute malignité avec un important syndrome médiastinal et surtout gynécomastie. Donc tumeur de médiastin antérieur avec un examen physique et une gynécomastie. Le diagnostic que vous devez évoquer c'est un choriocarcinome.

Et devant les tumeurs germinales, on a la biologie, la vaccination de bêta-Cg et l'alpha-fotopropil, le traitement de choriocarcinome et la chimiothérapie. Les autres tumeurs du médiastin antérieur, il faut citer le kyst pleuro-péricardique, c'est une anomalie du développement embryologique du péricard. Ce tumeur ou ce kyst pleuro-péricardique est souvent asymptomatique et de découverte pour truite.

Et la radiographie thoracique montrera un an passé arrondi au niveau de langue phrénique antérieure. La conduite à tenir souvent asymptomatique, il faut l'abstention sauf opérée, sauf complications. Les tumeurs du médiastin moyen sont dominés par les adénopathies.

Les adénopathies médiastinales qui peuvent être bénignes ou malignes, la sarcoïdose comme rétrologie des adénopathies médiastales bénignes, également la tuberculose et la pneumocorneuse. Pour les adénopathies médiastinales malignes, il faut passer aux hémopathies, la maladie de Hodgkin et la forme malade Hodgkinienne ou les adénopathies métastatiques. Les tumeurs autres du médiastin moyen qui sont bénignes sont les kysts brancogéniques.

C'est une malformation bénigne à proximité de l'axe tracheo-branchique. Sur le plan histologique, il est apprécié la présence d'un épithélium branchique. Le contenu de ce kyst est un contenu mecoué.

Ce sont des kysts de petite taille et souvent asymptomatiques. La TDM thoracique évoque le diagnostic, montre une nature kystique de ces kysts brancogéniques et montre le rapport avec l'axe tracheo-branchique, leur traitement chirurgical en raison du risque de complications. Enfin, pour les tumeurs du médiastin postérieur, les tumeurs du médiastin postérieur sont dominées par les tumeurs nerveuses qui peuvent être des chevallons, des neurones et neurofibrons, des neuroblastons ou des méningocelles.

Surtout, l'examen clinique est très important à la recherche de tâches caférolées. Si vous avez

une tumeur du médiastin postérieur avec des tâches caférolées, vous évoquez le diagnostic de neurinome ou neurofibrons. Vous avez ici à l'imagerie une opacité médiastinale postérieure et comme signe extra-thoracique des signes tâches caférolées.

Si vous avez une tumeur du médiastin postérieur avec des tâches caférolées, vous évoquez un neurofibrons ou un neurinome.